

Wie oft muss man sich steigern?

Evidenzbasierte Steigerungsfrequenzen und Wiederholungsbereiche für Maximalkraft, Muskelaufbau (Hypertrophie) und Kraftausdauer – gegliedert nach Trainingsalter (1–64+ Monate)

Zusammengestellt aus aktueller sport- und trainingswissenschaftlicher Literatur (u. a. ACSM Position Stand 2026 & 2009, aktuelle Dosis-Wirkungs-Metaanalysen). Kein medizinischer Rat – bei Vorerkrankungen ärztliche Rücksprache empfohlen.

1. Einordnung

Im März 2026 erschien die erste große Aktualisierung des zentralen Referenzwerks zum Krafttrainings-Progressionsdesign seit 17 Jahren: das ACSM Position Stand *"Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults"* – ein Overview of Reviews auf Basis von 137 systematischen Reviews mit über 30.000 Teilnehmenden. Zentrales Ergebnis: Training bis zum muskulären Versagen, die Gerätewahl (Maschine vs. freie Gewichte) und komplexe Periodisierung zeigten bei durchschnittlichen gesunden Erwachsenen keinen konsistenten Zusatznutzen. Konsistenz und individuell passendes Volumen schlagen starre Steigerungspläne. Die folgenden Tabellen liefern trotzdem die angefragten konkreten Zahlen – als Orientierung, nicht als starres Dogma.

Ergänzt wurde in dieser Version je Szenario der zugehörige **Wiederholungsbereich** (Anzahl Wiederholungen pro Satz), da die optimale Steigerungslogik direkt vom Trainingsbereich abhängt: Wer im 3er-Bereich für Maximalkraft trainiert, steigert anders als jemand im 20er-Bereich für Kraftausdauer.

2. Trainingsalter-Klassifikation

Trainingsstatus wird in der Literatur weniger über Kalenderzeit als über die Geschwindigkeit des Stress-Erholung-Anpassungs-Zyklus definiert: Ein Anfänger kann so schnell Fortschritte erzielen, wie er sich belasten und wieder erholen kann – ein Prozess von meist 48–72 Stunden. Bei Fortgeschrittenen der Mittelstufe dauert dieser Zyklus 1–2 Wochen bis maximal einen Monat, bei weit Fortgeschrittenen einen Monat oder länger, und der genaue Zeitpunkt der nächsten Leistungssteigerung wird kaum noch vorhersagbar.

Trainingsalter	Einordnung	Typische Progressions-Logik
0–3 Monate	Absoluter Anfänger	Fortschritt fast jede Einheit (neuronale Lernphase, Technikaufbau)
3–6 Monate	Anfänger / Novize	Fortschritt noch sehr häufig, von Einheit zu Einheit
6–12 Monate	Später Anfänger	Wöchentliche Steigerung wird zunehmend realistischer
12–24 Monate	Mittelstufe	Wöchentlich bis alle 2 Wochen, Mesozyklen sinnvoll
24–60 Monate	Fortgeschritten	Monatlich, im Rahmen periodisierter Mesozyklen
60–64+ Monate	Weit fortgeschritten	Über Makrozyklen (mehrere Monate), unregelmäßig, planbar nur grob

3. Maximalkraft

Referenzprotokoll (ACSM 2009): Für Anfänger werden Lasten empfohlen, die einem 8–12-Wiederholungsmaximum entsprechen (60–70 % des 1RM). Für Fortgeschrittene ab Mittelstufe wird ein breiterer Lastbereich von 1–12 RM in periodisierter Form empfohlen, mit späterer Betonung auf schwerem Training (1–6 RM) bei mindestens 3 Minuten Satzpause; in reinen Maximalkraft-Phasen wird ein zyklischer

Wechsel zwischen 70–100 % des 1RM empfohlen. Die neue ACSM-Synthese (2026) bringt das auf eine einfachere Kernformel: für Kraft werden 80 % des 1RM für 2–3 Sätze pro Übung empfohlen – das entspricht etwa 6–8 Wiederholungen.

Konkretes Steigerungskriterium (ACSM 2009): Ein Lastanstieg von 2–10 % wird angewandt, sobald die aktuelle Last für 1–2 Wiederholungen über der Zielwiederholungszahl in zwei aufeinanderfolgenden Einheiten bewältigt werden kann. Eine kontrollierte Studie bestätigt diese Größenordnung: graduelle Lastanstiege von 2–5 % pro Woche über acht Wochen führten zu signifikant größeren Maximalkraft-Verbesserungen als unstrukturiertes Training. Empfohlene Trainingsfrequenz: 2–3 Tage/Woche für Anfänger und Mittelstufe, 4–5 Tage/Woche für Fortgeschrittene.

Trainingsalter	Wiederholungsbereich	Maximal (theoretisch)	Optimal (nachhaltig)
0–3 Monate	8–12 Wdh (60–70 % 1RM)	Jede Einheit (+2,5–5 kg), solange Technik stabil bleibt	Jede Einheit; Fokus zunächst auf Bewegungsqualität
3–6 Monate	6–10 Wdh (70–80 % 1RM)	Fast jede Einheit	Wöchentlich, Doppelprogression im Wdh.-Bereich
6–12 Monate	5–8 Wdh (75–85 % 1RM)	Wöchentlich	Alle 1–2 Wochen
12–24 Monate	3–6 Wdh, periodisiert mit 8–10-Wdh-Blöcken	Alle 1–2 Wochen	Alle 2–4 Wochen (pro Mesozyklus)
24–60 Monate	1–6 Wdh in Schwerphasen, zyklisch mit 6–10 Wdh (70–100 % 1RM)	Monatlich	Alle 4–12 Wochen, zyklischer Lastwechsel
60–64+ Monate	1–5 Wdh in Peak-Phasen, periodisiert mit 6–12-Wdh-Blöcken; ACSM 2026: 80 % 1RM ≈ 6–8 Wdh, 2–3 Sätze	Alle paar Monate	Über Makrozyklen, nicht linear planbar

4. Muskelgröße (Hypertrophie)

Volumen statt reinem Lastfokus: Die aktuelle Dosis-Wirkungs-Metaregression zeigt einen abnehmenden Grenzertrag – Schoenfeld et al. fanden 0,38 % Hypertrophiezuwachs pro zusätzlichem wöchentlichem Satz, die neuere Metaregression von Pelland et al. (2024) schätzt 0,24 % Zuwachs pro zusätzlichem Satz bei durchschnittlich 12,25 Sätzen/Woche – ein Hinweis auf ein Plateau bei sehr hohem Volumen. Muskelgruppen sollten mindestens zweimal wöchentlich trainiert werden, um das Wachstum zu maximieren. Die neue ACSM-Empfehlung (2026) fasst dies als Zielgröße zusammen: rund 10 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche.

Last- vs. Wiederholungssteigerung: Plotkin et al. (2022, PeerJ) verglichen bei bereits trainierten Personen (mind. 1 Jahr Erfahrung) über 8 Wochen zwei reine Progressionsstrategien – Last steigern bei konstanten Wiederholungen vs. Wiederholungen steigern bei konstanter Last. Ergebnis: beide Strategien erwiesen sich als gleichermaßen wirksam für den Muskelaufbau. Praktisch etabliert hat sich dafür die **Doppelprogression**: Im gewählten Wiederholungsbereich arbeiten, bei Erreichen der Obergrenze für die Zielsatzzahl das Gewicht erhöhen, danach erneut durch den Bereich nach oben arbeiten. Die neuere "Repetition-Continuum"-Forschung zeigt zudem, dass Hypertrophie über ein sehr breites Wiederholungsspektrum hinweg erzielbar ist, solange nah genug am Muskelversagen trainiert wird.

Trainingsalter	Wiederholungsbereich	Maximal (theoretisch)	Optimal (nachhaltig)
0–3 Monate	8–12 Wdh (ACSM-Kernbereich)	Jede Einheit (Wdh. zuerst steigern)	Jede Einheit bis Wdh.-Obergrenze, dann Last+
3–6 Monate	8–12 Wdh, Doppelprogression	Wöchentlich	Wöchentlich (Doppelprogression)
6–12 Monate	6–12 Wdh, vereinzelt bis 15	Wöchentlich	Alle 1–2 Wochen
12–24 Monate	6–15 Wdh, variabel je Mesozyklus	Alle 1–2 Wochen	Pro Mesozyklus (3–6 Wochen) Volumen/Last steigern
24–60 Monate	5–20 Wdh je nach Phase (breites Spektrum wirksam)	Pro Mesozyklus	Periodisiert; Volumen schrittweise Richtung MRV steigern (~10 Sätze/Muskel/Woche als Zielgröße)
60–64+ Monate	5–30 Wdh, stark variabel je Übung/Phase	Pro Makrozyklus	Langsame, geplante Wellenperiodisierung

5. Kraftausdauer (lokale muskuläre Ausdauer)

Referenzprotokoll (ACSM 2009): Für lokales Kraftausdauertraining werden leichte bis moderate Lasten (40–60 % des 1RM) bei hohen Wiederholungszahlen (über 15) mit kurzen Satzpausen (unter 90 Sekunden) empfohlen. Die reverse lineare Periodisierung (hohe Anfangsintensität bei niedrigem Volumen, das im Verlauf zunimmt, während die Intensität sinkt) hat sich für Verbesserungen der Muskelausdauer als besonders wirksam gezeigt.

Wichtige Einschränkung aus neuerer Forschung: Manche Autoren stellen infrage, ob Kraftausdauer überhaupt eine eigenständige Trainingsgröße ist – die Anpassungen scheinen last-, geschwindigkeits- und teils übungsspezifisch zu sein, statt einer separaten, generischen Ausdauerphase zu bedürfen. Dropsets gelten dabei als sinnvolle Progressionsmethode für Fortgeschrittene, die bereits drei oder mehr konventionelle Sätze pro Muskelgruppe absolvieren.

Trainingsalter	Wiederholungsbereich	Maximal (theoretisch)	Optimal (nachhaltig)
0–3 Monate	15–20 Wdh (50–60 % 1RM)	Jede Einheit (Wdh. zuerst steigern)	Jede Einheit
3–6 Monate	15–20 Wdh (45–60 % 1RM)	Wöchentlich	Wöchentlich
6–12 Monate	15–25 Wdh (40–55 % 1RM)	Wöchentlich	Alle 1–2 Wochen
12–24 Monate	15–25 Wdh, Sätze/Dichte erhöhen	Alle 1–2 Wochen	Pro Mesozyklus, danach Last/Dichte erhöhen
24–60 Monate	20–30 Wdh oder Dropsets/ Zeitunterspannung	Pro Mesozyklus	Periodisiert (z. B. reverse-linear), + Dropsets bei 3+ Sätzen
60–64+ Monate	20–30+ Wdh, inkl. zeitbasierter Protokolle	Pro Makrozyklus	Stark individualisiert, wellenförmig

6. Kritische Einordnung

Die älteren ACSM-Zahlen (2009) sind nicht unumstritten. Eine methodische Kritik kommt zu dem Schluss, dass die Behauptung, Programme für Fortgeschrittene müssten sich grundlegend von denen für Anfänger unterscheiden, größtenteils unbelegt ist – einfaches, niedervolumiges, zeiteffizientes Training sei unabhängig vom Trainingsstatus ähnlich wirksam wie die komplexen, hochvolumigen Protokolle der offiziellen Empfehlungen.

Die neue ACSM-Synthese (2026) bestätigt das im Kern. Programme sollten auf persönliche Ziele, Freude und Sicherheit zugeschnitten werden, um die langfristige Einhaltung zu maximieren – ein zu anspruchsvolles Programm verliert seine Wirksamkeit, wenn es nicht durchgehalten wird. Individualisierung schlägt starre Regeln.

Praktisches Fazit: Die Tabellen liefern eine evidenzgestützte Orientierung inklusive Wiederholungsbereich je Szenario. Die robusteste Einzelerkenntnis aus der aktuellsten und umfangreichsten verfügbaren Evidenzsynthese bleibt aber: Konsistenz und ausreichender Trainingsreiz schlagen exakte Steigerungsfahrpläne. Die Doppelprogression ist für alle drei Ziele ein einfaches, gut belegtes Werkzeug – und mit steigendem Trainingsalter wird automatisch mehr Geduld bei der Steigerungsfrequenz nötig.

Quellenverzeichnis (Auswahl)

- American College of Sports Medicine (2026). Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*.
- Ratamess, N. A. et al. (2009). Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. ACSM Position Stand. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(3), 687–708.
- Fisher, J., Steele, J. & Smith, D. (2013). A critical analysis of the ACSM position stand on resistance training: insufficient evidence to support recommended training protocols.
- Pelland, J. C. et al. (2024). The Resistance Training Dose-Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gain.
- Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073–1082.
- Schoenfeld, B. J., Grgic, J. & Krieger, J. (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? *Journal of Sports Sciences*, 37(11), 1286–1295.
- Plotkin, D. et al. (2022). Progressive overload without progressing load? The effects of load or repetition progression on muscular adaptations. *PeerJ*, 10, e14142.
- Chaves, T. S. et al. (2024). Effects of Resistance Training Overload Progression Protocols. *International Journal of Sports Medicine*, 45, 504–510.
- Schoenfeld, B. J. et al. (2021). Loading Recommendations for Muscle Strength, Hypertrophy, and Local Endurance: A Re-Examination of the Repetition Continuum. *Sports*, 9(2), 32.
- Grgic, J., Schoenfeld, B. J. & Latella, C. (2019). Resistance training frequency and skeletal muscle hypertrophy: A review of available evidence.

Hinweis: Dieses Dokument fasst öffentlich zugängliche Forschung zusammen und ersetzt keine individuelle Trainings- oder medizinische Beratung. Alle Wiederholungs- und Steigerungsangaben sind Orientierungswerte; individuelle Erholungsfähigkeit, Technik, Ernährung und Schlaf beeinflussen die tatsächlich sinnvolle Progressionsrate erheblich.